BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

40



FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 40

Troubles des conduites alimentaires

Conduites addictives, anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique : critères diagnostiques, facteurs, physiopathologie, complications somatiques et prise en charge

Formules, définitions et valeurs repères · à connaître pour l'épreuve E2

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN · FICHE DE RÉVISION

Chapitre 40 – Troubles des conduites alimentaires

Formules, définitions et valeurs repères

Cette fiche rassemble, partie par partie, les définitions et les classifications (DSM-5-TR, anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique, ARFID et autres TCA, addiction, usage et mésusage, tolérance, sevrage, craving, verre standard, Gayet-Wernicke et Korsakoff, hyperémèse cannabinoïde, syndrome de renutrition inappropriée), les critères et scores (gravité DSM-5-TR, critères d'hospitalisation HAS 2010, SCOFF-F, AUDIT et AUDIT-C, Fagerström), les formules avec leurs unités et un exemple chiffré tiré du cours (IMC, pourcentage de perte de poids, poids cible et durée de reprise, surplus énergétique, grammes d'alcool et verres standard, énergie de l'alcool, alcoolémie de Widmark, paquets-années, thiamine, apport protéique) et les valeurs repères à connaître pour l'épreuve E2. Elle complète le cours du chapitre, sans le remplacer.

Sommaire de la fiche

40.3 Cadre général : classification DSM-5-TR, épidémiologie, repérage....2
40.3.1 Les conduites addictives : définitions et trouble de l'usage....3
40.3.1 L'alcool : verre standard, alcoolémie, repérage, sevrage....4
40.3.1 Thiamine et encéphalopathie de Gayet-Wernicke ; nutrition de l'alcoolique....5
40.3.1 Tabac, cannabis et autres substances....6
40.3.2 L'anorexie mentale....7
40.3.3 La boulimie....8
40.3.4 L'hyperphagie boulimique....9
40.9 et 40.11 Études de cas : calculs corrigés....10

40.3 Cadre général : classification DSM-5-TR, épidémiologie, repérage

Définitions

Terme	Définition
DSM-5-TR	Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition, texte révisé (American Psychiatric Association, 2022) : classification utilisée en recherche et en clinique ; la CIM-11 de l'OMS (2022) lui est très proche
Changements du DSM-5 (2013)	aménorrhée retirée des critères de l'anorexie mentale ; hyperphagie boulimique devenue un trouble à part entière ; création de l'ARFID
Trouble des conduites alimentaires (TCA)	perturbation persistante de l'alimentation ou du comportement alimentaire qui retentit sur la santé physique ou la vie sociale, ce qui la distingue d'un comportement simplement inhabituel (régime, végétarisme, jeûne religieux)
Crise de boulimie	ingestion, en un temps limité (par exemple moins de 2 heures), d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient, avec un sentiment de perte de contrôle
Comportement compensatoire	vomissements provoqués, laxatifs, diurétiques ou autres médicaments, jeûne ou exercice physique excessif, destinés à éviter la prise de poids
ARFID	trouble de l'alimentation sélective et évitante : restriction ou évitement entraînant perte de poids, carence, dépendance à des compléments ou gêne sociale, sans préoccupation pour le poids ou la silhouette ; profils sensoriel, peur d'une conséquence (étouffement, vomissement), manque d'intérêt ; à distinguer de la néophobie normale (2 à 6 ans)
Pica	ingestion répétée, pendant au moins 1 mois, de substances non nutritives (terre, craie, glace, papier), inappropriée au stade de développement ; rechercher une carence en fer
Mérycisme	régurgitations répétées d'aliments, remâchés, ravalés ou recrachés, sans cause digestive ; à distinguer du reflux gastro-œsophagien
Autres TCA spécifiés	anorexie mentale atypique (tous les critères, poids normal malgré une perte importante), boulimie ou hyperphagie de faible fréquence ou de courte durée, trouble purgatif (purges sans crises), syndrome d'alimentation nocturne

Terme	Définition
TCA non spécifiés	trouble alimentaire cliniquement significatif dont le clinicien ne précise pas la forme
Orthorexie, bigorexie	obsession de manger « sain » ; dysmorphie musculaire : ce ne sont pas des diagnostics du DSM-5-TR
SCOFF-F	questionnaire de repérage des TCA en 5 questions fermées (vomissements, perte de contrôle, perte de plus de 6 kg en 3 mois, se trouver trop gros, nourriture qui domine la vie) ; positif à partir de 2 réponses ; outil de repérage, pas de diagnostic

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Prévalence vie entière (Hudson 2007), femmes / hommes	anorexie 0,9 % / 0,3 % ; boulimie 1,5 % / 0,5 % ; hyperphagie boulimique 3,5 % / 2,0 %
SCOFF-F positif	≥ 2 réponses positives sur 5

> **À RETENIR**
>
> ► Ce qui sépare la boulimie de l'hyperphagie boulimique, c'est la présence ou l'absence de compensations régulières ; ce qui sépare la boulimie de l'anorexie avec crises et purges, c'est le poids : significativement bas dans l'anorexie.

40.3.1 Les conduites addictives : définitions et trouble de l'usage

Définitions

Terme	Définition
Substance psychoactive	substance qui modifie le fonctionnement du cerveau (perceptions, humeur, conscience, comportement) : alcool, nicotine, cannabis, opioïdes, cocaïne, amphétamines, certains médicaments
Addiction	perte de contrôle d'un comportement de consommation poursuivi malgré ses conséquences négatives
Usage simple	usage à faible risque, sans dommage
Mésusage	usage à risque (expose à des dommages sans en avoir encore causé : au-delà des repères, conduite après avoir bu, grossesse) ou usage nocif (dommages physiques, psychiques ou sociaux déjà présents), sans forcément de dépendance
Dépendance	perte de contrôle, craving, tolérance et syndrome de sevrage
Tolérance	diminution de l'effet d'une même dose, qui pousse à augmenter les quantités
Sevrage	ensemble de signes physiques et psychiques qui apparaissent à l'arrêt ou à la diminution de la consommation
Craving	envie impérieuse, irrépressible, de consommer une substance
Trouble de l'usage d'une substance (DSM-5-TR)	mode d'usage problématique avec altération du fonctionnement ou souffrance, défini par au moins 2 des 11 critères sur 12 mois : perte de contrôle (1 à 4), altération sociale (5 à 7), usage risqué (8, 9), critères pharmacologiques (10 tolérance, 11 sevrage)
Circuit de la récompense	voie dopaminergique (aire tegmentale ventrale vers noyau accumbens) activée par les substances ; le cortex préfrontal, moins efficace, ne freine plus la consommation : perte de contrôle

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Gravité du trouble de l'usage	léger 2-3 critères ; modéré 4-5 ; sévère ≥ 6
Décès attribuables (2015)	alcool ≈ 41 000 par an ; tabac ≈ 75 000 par an

40.3.1 L'alcool : verre standard, alcoolémie, repérage, sevrage

Définitions

Terme	Définition
Verre standard	quantité de boisson alcoolisée contenant environ 10 g d'alcool pur (25 cl de bière à 5 %, 10 cl de vin à 12 %, 3 cl de whisky à 40 %)
Alcool déshydrogénase (ADH)	enzyme cytosolique qui oxyde l'éthanol en acétaldéhyde (à ne pas confondre avec l'hormone antidiurétique) ; saturée dès de faibles concentrations, d'où une élimination à vitesse à peu près constante
MEOS	système microsomal d'oxydation de l'éthanol (CYP2E1), inductible
ALDH2	aldéhyde déshydrogénase mitochondriale, qui oxyde l'acétaldéhyde en acétate ; ces oxydations produisent un excès de NADH
Alcoolémie	concentration d'alcool dans le sang, en g/L ; estimée par la formule de Widmark
AUDIT	questionnaire de l'OMS en 10 questions notées de 0 à 4 (score 0 à 40) : questions 1 à 3 consommation, 4 à 6 dépendance, 7 à 10 dommages
AUDIT-C	version courte : les 3 premières questions de l'AUDIT, score sur 12
RPIB	repérage précoce et intervention brève (HAS 2014), recommandés à tous les professionnels de santé, y compris le diététicien
Marqueurs biologiques	GGT (induction enzymatique, normalisation en 2 à 3 semaines d'arrêt), VGM > 100 fL (macrocytose, normalisation en 3 mois environ), ASAT/ALAT > 2, CDT (le plus spécifique d'une consommation > 50 à 60 g/j) ; ils servent à objectiver et suivre, pas à dépister
Syndrome de sevrage alcoolique	6 à 24 h après la dernière prise : tremblements, sueurs, tachycardie, anxiété, insomnie, nausées ; acte médical (benzodiazépines, hydratation, électrolytes, thiamine)
Delirium tremens	complication grave du sevrage, en général entre le 2e et le 4e jour : confusion, hallucinations, fièvre, déshydratation, agitation ; peut être mortel

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Alcool pur	**masse (g) = volume (mL) × degré / 100 × 0,8 (masse volumique de l'éthanol, g/mL)**	canette de 50 cl à 8 % : 500 × 8 / 100 × 0,8 = 32 g ; bouteille de vin de 75 cl à 12 % : 72 g
Verres standard	**nombre = alcool (g) / 10**	M. Patrick D. : 4 × 32 = 128 g/j = 12,8 verres/j ; 12,8 × 7 = 89,6 verres/semaine
Énergie de l'alcool	**énergie (kcal) = alcool (g) × 7**	un verre : 70 kcal ; M. Patrick D. : 128 × 7 = 896 kcal/j
Alcoolémie (Widmark)	**alcoolémie (g/L) = alcool (g) / [poids (kg) × K], K = 0,7 (homme), 0,6 (femme)**	M. Patrick D., 64 kg, une canette : 32 / (64 × 0,7) = 32 / 44,8 = 0,71 g/L ; femme de 55 kg, 3 coupes de 10 cl à 12 % : 28,8 / 33 = 0,87 g/L
Durée d'élimination	**durée (h) = alcoolémie (g/L) / vitesse d'élimination (g/L/h)**	0,71 / 0,15 ≈ 4,8 h à 0,71 / 0,10 ≈ 7,1 h ; femme de 55 kg : (0,87 − 0,5) / 0,15 ≈ 2,5 h avant de repasser sous 0,5 g/L
Rapport ASAT/ALAT	**rapport = ASAT / ALAT, évocateur d'une atteinte alcoolique s'il dépasse 2**	M. Patrick D. : 96 / 44 = 2,2

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Repères Santé publique France et INCa (2017)	≤ 10 verres/semaine, ≤ 2 verres/jour, des jours sans alcool ; grossesse : zéro alcool

Paramètre	Valeur
Seuils de conduite	0,5 g/L de sang (0,25 mg/L d'air expiré) ; 0,2 g/L en permis probatoire et pour les conducteurs de transport en commun
Élimination de l'alcool	0,10 à 0,15 g/L/h
AUDIT (HAS)	mésusage probable ≥ 8 (homme), ≥ 7 (femme) ; dépendance probable > 12
AUDIT-C	positif à partir de 4 (homme), 3 (femme)
VGM ; ASAT/ALAT	> 100 fL (macrocytose) ; > 2

À RETENIR

► Le dosage biologique ne remplace pas la question : « combien de verres buvez-vous en moyenne par jour ? », puis conversion en verres standard et questionnaire validé.

40.3.1 Thiamine et encéphalopathie de Gayet-Wernicke ; nutrition de l'alcoolique

Définitions

Terme	Définition
Thiamine pyrophosphate (TPP)	forme active de la vitamine B1, coenzyme de la pyruvate déshydrogénase, de l'α-cétoglutarate déshydrogénase et de la transcétolase
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke	atteinte cérébrale aiguë par carence en thiamine, souvent déclenchée par un apport de glucose sans thiamine : confusion, ataxie, troubles oculomoteurs (nystagmus) ; lésions du thalamus et des corps mamillaires
Syndrome de Korsakoff	amnésie antérograde avec fabulations, séquelle souvent irréversible d'une carence en thiamine non traitée
Règle « thiamine avant le glucose »	chez tout patient alcoolodépendant, dénutri, anorexique ou qui vomit depuis longtemps, la thiamine est donnée avant ou en même temps que le premier apport glucidique
Calories vides	l'alcool apporte de l'énergie (7 kcal/g) sans micronutriments ; carences en B1, B9, magnésium, zinc ; hypoglycémie, stéatose, dénutrition

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Dose de thiamine du Gayet-Wernicke	**dose (mg/j) = 500 mg × 3 prises, par voie IV**	500 × 3 = 1 500 mg/j, avant tout soluté glucosé (M. Patrick D.)
Apport protéique du dénutri alcoolique	**protéines (g/j) = poids (kg) × 1,2 à 1,5 g/kg/j**	M. Patrick D., 64 kg : 64 × 1,2 = 77 g à 64 × 1,5 = 96 g/j ; M. Bernard L., 59 kg : 71 à 89 g/j
Part de l'alcool dans l'apport énergétique	**part (%) = énergie de l'alcool / besoin × 100**	bouteille de vin : 72 × 7 = 504 kcal/j, soit 504 / 2 000 × 100 = 25,2 % du besoin

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Réserves de thiamine	25 à 30 mg, épuisées en 2 à 3 semaines
Thiamine en prévention pendant le sevrage (SFA 2015)	250 à 500 mg/j
Gayet-Wernicke	thiamine 500 mg × 3/j IV, avant le glucose ; triade complète dans moins d'un cas sur cinq : traiter au moindre doute

À RETENIR

► Toute confusion chez un patient alcoolique ou dénutri fait administrer la thiamine sans attendre d'examen.

40.3.1 Tabac, cannabis et autres substances

Définitions

Terme	Définition
Nicotine	responsable de la dépendance ; atteint le cerveau en 10 secondes environ ; anorexigène (neurones POMC) et augmente la dépense énergétique
Test de Fagerström	questionnaire en 6 questions (Heatherton et coll., 1991), score de 0 à 10, évaluant la dépendance à la nicotine ; les plus informatives : délai réveil-première cigarette (≤ 5 min : 3 points) et nombre de cigarettes par jour
Paquet-année	unité d'exposition au tabac : un paquet de 20 cigarettes par jour pendant un an
THC et CBD	Δ9-tétrahydrocannabinol, psychoactif, qui active les récepteurs CB1 (orexigène : fringales) ; cannabidiol, non enivrant
Hyperémèse cannabinoïde	vomissements cycliques incoercibles chez un consommateur chronique quotidien de cannabis, soulagés par les douches ou bains très chauds ; seul traitement efficace : l'arrêt
Autres substances	cocaïne et amphétamines coupent l'appétit ; opioïdes et traitements de substitution : constipation, attirance pour le sucré, caries

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Paquets-années	**PA = (cigarettes par jour / 20) × années de tabagisme**	Mme Sophie L. : (20 / 20) × 20 = 20 paquets-années
Score de Fagerström	**somme des points des 6 questions**	Mme Sophie L. : 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 = 7 : dépendance forte
IMC après l'arrêt du tabac	**IMC = (poids + prise) / taille²**	Mme Sophie L., 1,66 m : 63 / 2,7556 = 22,9 ; 67 / 2,7556 = 24,3 ; 68 / 2,7556 = 24,7 kg/m²

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Fagerström	0-2 pas de dépendance ; 3-4 faible ; 5-6 moyenne ; 7-10 forte
Prise de poids à l'arrêt du tabac (HAS 2014)	+ 4 à 5 kg en moyenne, surtout la première année
Fumeurs quotidiens (18-75 ans, 2022)	24,5 %
Tabac info service	39 89

À RETENIR

► Pas de régime restrictif pendant le sevrage tabagique : il augmente le risque de rechute ; substituts bien dosés, 3 repas et collations planifiées, activité physique.

40.3.2 L'anorexie mentale

Définitions

Terme	Définition
Anorexie mentale	restriction des apports conduisant à un poids significativement bas, peur intense de prendre du poids et altération de la perception du poids ou de la forme du corps ; la faim est présente (ghréline élevée) mais combattue
Critères DSM-5-TR	A. restriction et poids significativement bas ; B. peur intense de grossir ou comportement qui empêche la prise de poids ; C. perception du corps altérée, influence excessive sur l'estime de soi ou déni de la gravité
Type restrictif	perte de poids par régime, jeûne ou exercice excessif, sans crises ni purges récurrentes dans les 3 derniers mois
Type avec crises de boulimie et purges	crises et/ou vomissements provoqués, laxatifs, diurétiques, lavements dans les 3 derniers mois
Syndrome de basse T3	baisse de la T3 et du tonus sympathique au cours du jeûne : bradycardie, hypothermie
Hypogonadisme hypogonadotrope	chute de la leptine qui supprime la sécrétion pulsatile de GnRH, donc de LH et FSH : aménorrhée
Lanugo, acrocyanose	duvet fin de la dénutrition sévère ; extrémités violacées et froides par vasoconstriction
Syndrome de renutrition inappropriée (SRI)	chute du phosphore, du potassium et du magnésium et rétention hydrosodée lors de la renutrition d'un patient dénutri, par élévation de l'insuline ; troubles du rythme, insuffisance cardiaque (développé au chapitre 41)
Repas thérapeutique	repas pris avec un soignant pour assurer les apports et réexposer aux aliments redoutés ; durée limitée (30 à 45 minutes), pas de négociation du contenu

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC	**IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)**	Inès : 41,0 / 1,65² = 41,0 / 2,7225 = 15,1 kg/m²
Perte de poids	**perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100**	Inès : (54,0 − 41,0) / 54,0 = 13,0 / 54,0 = 24,1 % en 8 mois ; 48,5 → 41,0 kg en 17 semaines : 7,5 / 48,5 = 15,5 %
Poids pour un IMC cible	**poids cible (kg) = IMC cible × taille²**	Inès : 18,5 × 2,7225 = 50,4 kg, soit 50,4 − 41,0 = 9,4 kg à reprendre
Durée de reprise	**durée (semaines) = poids à reprendre / vitesse de reprise (kg/semaine)**	Inès : 9,4 / 1 = 9,4 à 9,4 / 0,5 = 18,8 semaines ; adulte de 1,72 m, 44,5 kg : 10,2 / 0,5 = 20,4 à 10,2 / 0,2 = 51 semaines
Surplus énergétique de la reprise	**surplus (kcal/j) = vitesse (kg/semaine) × 7 000 / 7**	0,5 kg/semaine : 500 kcal/j ; 1 kg/semaine : 1 000 kcal/j ; 0,7 kg/semaine : 0,7 × 7 000 / 7 = 700 kcal/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Gravité DSM-5-TR (adulte, IMC kg/m²)	légère ≥ 17 ; modérée 16 à 16,99 ; sévère 15 à 15,99 ; extrême < 15 (percentiles chez l'enfant et l'adolescent)
Épidémiologie	début 14 à 17 ans ; SMR ≈ 5,9 (Arcelus 2011) ; évolution ≈ 50 % guérison, 30 % amélioration, 20 % chronicité
Hospitalisation HAS 2010, adulte	IMC < 14 ; perte de 20 % en 3 mois ; FC < 40/min ; PA < 90/60 mm Hg ; T < 35 °C ; K < 3 mmol/L ; P < 0,5 mmol/L ; Na < 125 mmol/L ; glycémie < 0,6 g/L symptomatique (< 0,3 g/L sinon) ; cytolyse > 10 × N

Paramètre	Valeur
Hospitalisation HAS 2010, adolescent	IMC < 14 après 17 ans, < 13,2 à 15-16 ans, < 12,7 à 13-14 ans ; perte > 2 kg/semaine ; pouls < 40/min ; PA systolique < 80 mm Hg ; T < 35,5 °C ; acétonurie ; glycémie < 0,6 g/L ; cytolyse > 4 × N
Vitesse de reprise (HAS 2010)	0,5 à 1 kg/semaine à l'hôpital ; 0,2 à 0,5 kg/semaine en ambulatoire
Risque de SRI (NICE 2006)	IMC < 16 ; perte > 15 % en 3 à 6 mois ; apports quasi nuls > 10 jours ; P, K ou Mg bas avant la renutrition ; survenue en 2 à 5 jours
Énergie de la reprise	≈ 7 000 kcal par kg de poids repris
Structure des repas ; calcium (ANSES 2021)	3 repas et 1 à 3 collations ; 1 150 mg/j de 11 à 17 ans

À RETENIR

► Des électrolytes normaux avant la renutrition n'excluent pas le SRI : les stocks intracellulaires sont épuisés ; thiamine avant les glucides, progression des apports, phosphore surveillé chaque jour la première semaine.

40.3.3 La boulimie

Définitions

Terme	Définition
Boulimie (bulimia nervosa)	crises de boulimie récurrentes et comportements compensatoires inappropriés, en moyenne au moins une fois par semaine pendant 3 mois, estime de soi dépendante du poids ; poids le plus souvent normal
Critère E	le trouble ne survient pas exclusivement pendant une anorexie mentale : si le poids est significativement bas, le diagnostic est l'anorexie avec crises et purges
Alcalose hypochlorémique	bicarbonates élevés et chlore bas par perte d'acide chlorhydrique (vomissements) ; les laxatifs donnent au contraire une acidose hyperchlorémique
Hypokaliémie	complication la plus dangereuse des purges : troubles du rythme, QT long, mort subite ; K < 3 mmol/L est un critère d'hospitalisation de l'adulte
Signe de Russell	callosités sur le dos de la main dues aux vomissements provoqués ; avec l'hypertrophie des parotides et les érosions dentaires
Cycle de la boulimie	restriction → crise → compensation → culpabilité → nouvelle restriction
Œdèmes à l'arrêt des purges	l'aldostérone, stimulée par la déshydratation chronique, reste élevée : rétention de sodium et d'eau, prise de 1 à 2 kg d'eau à annoncer

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC	**poids / taille²**	Manon : 60,0 / 1,68² = 60,0 / 2,8224 = 21,3 kg/m² (normal)
Énergie des crises	**énergie (kcal/semaine) = nombre de crises × énergie par crise**	Manon : 5 × 3 000 = 15 000 kcal/semaine, soit ≈ 2 143 kcal/j
Besoin rapporté au poids	**besoin (kcal/kg/j) = besoin / poids**	Manon : 2 000 / 60 = 33 kcal/kg/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Gravité DSM-5-TR (compensations par semaine)	légère 1 à 3 ; modérée 4 à 7 ; sévère 8 à 13 ; extrême ≥ 14 (Manon, 9 : sévère)
Interprétation du ionogramme	K < 3 mmol/L : urgence ; HCO_3^- > 28 mmol/L avec Cl^- bas : vomissements (Manon : K 2,9, HCO_3^- 33, Cl^- 90 mmol/L) ; HCO_3^- bas avec Cl^- élevé : laxatifs
Traitement (HAS 2019)	TCC en 1re intention ; 3 repas et 1 à 3 collations ; fluoxétine 60 mg/j (AMM boulimie)

À RETENIR

► Les laxatifs n'empêchent pas l'absorption des calories (elle a lieu dans l'intestin grêle) : ils font perdre surtout de l'eau et des électrolytes. Après un vomissement, se rincer la bouche et attendre avant de se brosser les dents.

40.3.4 L'hyperphagie boulimique

Définitions

Terme	Définition
Hyperphagie boulimique (binge eating disorder)	crises de boulimie récurrentes avec perte de contrôle et détresse marquée, sans comportements compensatoires réguliers ; TCA le plus fréquent, début souvent entre 20 et 30 ans, associé au surpoids et à l'obésité
Caractéristiques des crises (≥ 3 sur 5)	manger beaucoup plus vite que la normale ; jusqu'à une distension inconfortable ; de grandes quantités sans faim ; seul par gêne ; dégoût de soi, déprime ou culpabilité après

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC	**poids / taille²**	M. Karim B. : 112 / $1{,}75^2$ = 112 / 3,0625 = 36,6 kg/m²
Objectif de perte de poids	**perte (kg) = poids × 5 à 10 %**	M. Karim B. : 112 × 0,05 = 5,6 kg à 112 × 0,10 = 11,2 kg

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Gravité DSM-5-TR (crises par semaine)	légère 1 à 3 ; modérée 4 à 7 ; sévère 8 à 13 ; extrême ≥ 14 (M. Karim B., 5 : modérée)
Fréquence minimale	au moins 1 crise par semaine pendant 3 mois
Lien avec l'obésité	20 à 30 % des personnes qui consultent pour une obésité

À RETENIR

► Le premier objectif est l'arrêt des crises (repas réguliers, TCC), pas la perte de poids : un régime restrictif entretient le cycle restriction-crise.

40.9 et 40.11 Études de cas : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
M. Patrick D., 52 ans, 1,78 m, 64 kg (72 kg il y a 6 mois)	**IMC = 64 / 3,1684 = 20,2 ; perte = 8 / 72 = 11,1 % en 6 mois**	perte ≥ 10 % en 6 mois : dénutrition (HAS 2019), modérée (perte < 15 %, IMC > 17) ; 128 g/j d'alcool, AUDIT 26
Théo, 19 ans, 1,80 m, 63 kg (68 kg habituellement)	**perte = 5 / 68 = 7,4 % ; IMC = 63 / 3,24 = 19,4**	hyperémèse cannabinoïde, K 3,2 mmol/L
Hugo, 17 ans, 1,78 m, 52 kg (63 kg il y a 10 mois)	**perte = 11 / 63 = 17,5 % ; IMC = 52 / 3,1684 = 16,4 ; disponibilité énergétique = (1 800 − 900) / 47 = 19,1 kcal/kg MM/j**	FC 42/min, T 35,8 °C
Mme Claire V., 24 ans, DT1, 1,65 m, 52 kg (58 kg)	**perte = 6 / 58 = 10,3 % ; IMC = 52 / 2,7225 = 19,1**	HbA1c 11,2 % : insuline omise
Mme Nadia K., enceinte de 10 semaines	**verre de 12 cl à 12 % : 120 × 12 / 100 × 0,8 = 11,52 g ; 6 verres : 69,1 g/semaine**	6,9 verres standard par semaine ; repère en grossesse : zéro
Internat, 400 élèves	**SCOFF-F positif : 38 / 400 = 9,5 % ; filles 29 / 210 = 13,8 % ; garçons 9 / 190 = 4,7 %**	repérage, pas diagnostic
M. Bernard L., 63 ans, cirrhose, 1,72 m, 59 kg	**IMC = 59 / 2,9584 = 19,9 ; 6 verres de 12,5 cl à 12 % = 6 × 12 = 72 g/j ; énergie = 59 × 35 = 2 065 kcal/j ; protéines 71 à 89 g/j**	7,2 verres standard par jour
Mme Élodie R., 35 ans, 1,63 m, 104 kg	**IMC = 104 / 2,6569 = 39,1 kg/m²**	3 crises par semaine : hyperphagie légère
Lucie, 20 ans, 58 kg	**11 verres par semaine dont 8 le samedi ; AUDIT-C 7 ≥ 3 (femme)**	au-delà de 10 par semaine et de 2 par jour : repérage positif, compléter par l'AUDIT
M. Ahmed S., 45 ans, méthadone, 1,76 m, 82 kg (70 kg)	**prise = 12 / 70 = 17,1 % ; IMC = 82 / 3,0976 = 26,5 ; 1,5 L de soda : 159 g de sucres × 4 = 636 kcal**	report sur le sucré des opioïdes
Mme Sarah T., 28 ans, 1,64 m, 44 kg	**IMC = 44 / 2,6896 = 16,4 kg/m²**	K 3,1 mmol/L, HCO_3^- 31 mmol/L : purges ; anorexie avec crises et purges
Mme Josiane P., 72 ans, 1,58 m, 51 kg (57 kg)	**perte = 6 / 57 = 10,5 % ; IMC = 51 / 2,4964 = 20,4 ; porto 3 × 50 × 0,19 × 0,8 = 22,8 g + vin 375 × 0,12 × 0,8 = 36 g = 58,8 g/j**	5,9 verres standard par jour (repère : 2)